

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Gerência da Qualidade e Desenvolvimento Institucional

DIRETORIA TÉCNICA

DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Gerência de Enfermagem
Gerências da Atenção Primária Distritais

Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal

Nota Técnica Conjunta nº 05/2025 – SES.DGE.DAP.DTE

Assunto: Prescrição de Ácido Fólico, Sulfato Ferroso, Carbonato de Cálcio e Vitamina A + Vitamina D pelo Médico, Enfermeiro, Nutricionista e/ou Farmacêutico na assistência à Pré-concepção, Pré-natal e Puericultura

A assistência à pré-concepção, pré-natal e puericultura são etapas importantes do cuidado à saúde da mulher e do bebê, abrangendo desde o planejamento da gravidez até os primeiros anos de vida da criança, e a suplementação nutricional desempenha um papel crucial em todas estas etapas.

1. PRÉ-CONCEPÇÃO

O preparo pré-concepcional consiste num conjunto de cuidados de saúde adotados no período que antecede a concepção. É importante para a saúde reprodutiva, pois previne agravos na gestação, parto e puerpério, reduzindo a morbimortalidade materna e infantil e o risco de doenças genéticas. Neste momento, a suplementação também torna-se uma estratégia importante.

1.1. Ácido Fólico

As usuárias devem ser suplementadas com **Ácido Fólico** no período da pré-concepção para prevenção de Doença do Tubo Neural (DTN) e durante toda a gestação para a prevenção da anemia, pois este micronutriente não é facilmente atingido somente pela alimentação. A suplementação pode ocorrer conforme o **Quadro 01**.

Quadro 01. Prescrição de Ácido Fólico na Pré-concepção

SUPLEMENTO	PRESCRITOR	ORIENTAÇÕES GERAIS
Ácido Fólico 5mg	Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos	➤ Mulheres que planejam engravidar podem iniciar ao menos 30 dias antes de engravidar .

Fonte: NGQP, 2025.

2. PRÉ-NATAL

A suplementação de **Ácido Fólico** e **Sulfato Ferroso** durante a gestação é recomendada como parte do cuidado no pré-natal para reduzir o risco de baixo peso ao nascer da criança, anemia e deficiência de ferro na gestante.

Na mesma lógica da prevenção, o Ministério da Saúde orienta o uso universal do **Carbonato de Cálcio** para gestantes com início na 12ª semana de gestação até o momento do parto, com objetivo de prevenir a pré-eclâmpsia.

2.1. Ácido Fólico, Sulfato Ferroso e Carbonato de Cálcio

O **Quadro 02** orienta sobre a prescrição de Ácido Fólico, Sulfato Ferroso e Carbonato de Cálcio durante a Gestação.

Quadro 02. Prescrição de Ácido Fólico, Sulfato Ferroso e Carbonato de Cálcio na Gestação

SUPLEMENTO	PRESCRITOR	ORIENTAÇÕES GERAIS	
Ácido fólico 5mg	Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos	Suplementar com Ácido Fólico : ➤ 5mg/dia até a 16ª semana gestacional.	
Sulfato Ferroso <i>Equivalente a 40mg de Ferro Elementar</i>	Médicos, Enfermeiros, Nutricionistas e Farmacêuticos <i>(Mediante a realização de Hemograma*)</i>	*Hemoglobina > 11g/dL = Ausência de anemia	Suplementar com Sulfato Ferroso - 40 mg de ferro elementar ao dia: ❖ Recomenda-se 01 (um) comprimido 30 minutos antes do almoço, de preferência com suco de frutas cítricas; ❖ Iniciar no 2º trimestre ou 20ª semana de gestação; ❖ Manter até 3 a 6 meses após o parto.



SUPLEMENTO	PRESCRITOR	ORIENTAÇÕES GERAIS	
Sulfato Ferroso <i>Equivalente a 40mg de Ferro Elementar</i>	Médicos e Enfermeiros <i>(Mediante a realização de Hemograma)</i>	*Hemoglobina entre 8 e 11g/dL = Anemia leve a moderada	Suplementar com Sulfato Ferroso - 120 a 240mg de ferro elementar ao dia: ❖ Recomenda-se 05 (cinco) comprimidos de sulfato ferroso de 40 mg via oral. Sugere-se a posologia de 02 pela manhã, 02 à tarde e 01 à noite. Sempre 01 (uma) hora antes das refeições e de preferência com suco de frutas cítricas.
		*Hemoglobina < 8g/dL = Anemia grave	❖ Referenciar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, mantendo cuidado compartilhado na APS (SEI N° 20.0.022906-3).
		<i>Repetir hemograma com a dosagem de hemoglobina entre 30 e 60 dias para controle de cura:</i> ❖ A solicitação de hemograma poderá ser feita por médicos e/ou enfermeiros; ❖ Se os níveis estiverem subindo manter tratamento até a hemoglobina atingir 11g/dl, quando deverá ser iniciada a dose de suplementação (1 comprimido ao dia, com 40mg de ferro elementar); ❖ Se a hemoglobina permanecer em níveis estacionários ou se diminuir, referenciar ao Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco, mantendo cuidado compartilhado na APS (SEI N° 20.0.022906-3); ❖ Em casos de suspeita ou confirmação de <u>Doenças Falciforme</u> a suplementação de ferro deverá ser avaliada exclusivamente por médico.	
Carbonato de Cálcio <i>A apresentação associada disponível no elenco básico de medicamentos poderá ser usada como alternativa: Carbonato de Cálcio 1250 mg (500mg de Cálcio Elementar) + Colecalciferol 400UI - Comprimido</i>	Médicos	Recomenda-se a suplementação universal de todas as gestantes com início na 12ª semana de gestação até o momento do parto: ❖ Carbonato de Cálcio 1250 mg (500mg de Cálcio Elementar) + Colecalciferol 400UI = 1 comprimido 12/12h OU Carbonato de Cálcio (1.250 mg, equivalente a 500mg de cálcio elementar) = 1 comprimido 12/12h diários. Importante: ❖ O período gestacional máximo para o início da prescrição da suplementação de cálcio como prevenção é de até 20 semanas, após este período não tem mais indicação; ❖ O suplemento contendo cálcio não deve ser ingerido junto com a suplementação de ferro : ➢ É necessário um intervalo de 02 (duas) horas entre os suplementos para garantir a absorção adequada de cada um; ➢ Orienta-se que o cálcio não seja ingerido em jejum , mas como ele pode interagir com uma grande variedade de alimentos que podem afetar a sua absorção sugere-se: Ingestão no período da noite com um copo de leite ou suco de frutas , por exemplo.	

Fonte: NGQP, 2025.



3. PUERICULTURA

A puericultura refere-se ao acompanhamento periódico da saúde da criança, visando a promoção, prevenção e tratamento de doenças, além de orientar os pais e cuidadores sobre o desenvolvimento infantil e a importância da suplementação nutricional nesse processo.

3.1. Sulfato Ferroso

Desde o pré-natal, a deficiência de ferro tem repercussões importantes e deletérias de longo prazo no desenvolvimento da criança (ex: infecções frequentes, irritabilidade, apatia, anorexia, falta de atenção, dificuldades de aprendizagem e baixo rendimento cognitivo/intelectual, por atraso do desenvolvimento neurológico e psicomotor fetal) cujo comprometimento pode ser irreversível.

Desta forma, faz-se necessária uma avaliação criteriosa de fatores de risco envolvendo a gestante e o bebê, tais como:

- Histórico de saúde da gestante no pré-natal;
- Intercorrências no nascimento;
- Crianças em aleitamento misto ou desmamadas,
- Avaliação do desenvolvimento e crescimento da criança;
- Presença de sinais clínicos de anemia,
- Vulnerabilidade social,
- Ingesta alimentar adequada, entre outros.

3.1.1. Prescrição de Sulfato Ferroso

Considerando a suplementação universal de ferro aos recém-nascidos, o **Quadro 3** expõe de maneira simplificada a quantidade a ser otimizada em cada caso específico, mas a avaliação individual de cada caso é extremamente importante para a prescrição ideal.

Todo o prematuro e recém-nascido com baixo peso ao nascer, **cl clinicamente estável e sem transfusões**, deverá receber suplementação de ferro a partir do 30º (trigésimo) dia de nascimento e conforme quadro abaixo.

Nos casos de crianças com fatores de risco para anemia (**item 3.1**), solicitar hemograma para monitoramento, conforme **Quadro 03**. Caso o hemograma evidenciar anemia, mesmo com suplementação, encaminhar para avaliação médica.



Quadro 03. Recomendações de Suplementação de Sulfato Ferroso

SITUAÇÃO	PRESCRITOR	RECOMENDAÇÃO	MONITORAMENTO
Recém-nascido a termo , de peso adequado para idade gestacional em aleitamento materno	Médicos, Enfermeiros, Nutricionistas e Farmacêuticos	1mg/Kg peso/dia a partir do 6º mês (ou da introdução de outros alimentos) até o 24º mês da vida	Avaliar com a equipe a necessidade ou não da suplementação, considerando cada caso.
Crianças em desmame precoce (< 4 meses) , mesmo a termo e com o peso adequado	Médicos, Enfermeiros, Nutricionistas e Farmacêuticos	1mg/Kg peso/dia a partir dos 4 meses até os 24 meses	Solicitar/avaliar hemograma entre 9 e 12 meses.
Recém-nascido pré-termo e recém-nascido de baixo peso até 1,5Kg	Médicos ou Enfermeiros	2mg/Kg peso/dia a partir do 30º dia de vida até durante um ano. Posteriormente, 1mg/Kg peso/dia por mais um ano, até completar 24 meses, ou conforme avaliação médica.	Solicitar/avaliar hemograma com 15 meses.
Recém-nascido pré-termo com peso entre 1,5Kg e 1Kg	Médico	3mg/Kg peso/dia a partir do 30º dia de vida até durante um ano. Posteriormente, 1mg/Kg peso/dia por mais um ano, até completar 24 meses, ou conforme avaliação médica.	Solicitar/avaliar hemograma aos 6 e 15 meses.
Recém-nascido pré-termo com peso menor que 1Kg	Médico	4mg/Kg peso/dia a partir do 30º dia de vida até durante um ano. Posteriormente, 1mg/Kg peso/dia por mais um ano, até completar 24 meses, ou conforme avaliação médica.	Solicitar/avaliar hemograma aos 6 e 15 meses.

IMPORTANTE:

- ❖ A solicitação de hemograma poderá ser feita por médicos e/ou enfermeiros;
- ❖ Recém-nascidos prematuros, incluindo os com peso $\leq 1,5$ kg, recomenda-se iniciar a suplementação de ferro a partir de 30 dias de vida, **se o bebê estiver clinicamente estável e sem transfusões**, até completar 24 meses;
- ❖ Atentar-se na concentração de ferro elementar do produto Sulfato Ferroso disponível na farmácia, para cálculo das gotas correspondentes para proceder a prescrição;
- ❖ Para o cálculo da dose em cada situação, sugere-se utilizar calculadora para dose do sulfato ferroso através do link <https://aps.bvs.br/apps/calculadoras/?page=3>;
- ❖ Em casos de suspeita ou confirmação de **Doenças Falciformes** a suplementação de ferro deverá ser avaliada exclusivamente por médicos.
- ❖ O sulfato ferroso deve ser administrado:
 - Longe das refeições ou leite,
 - 30 min a 1 hora antes ou 2 horas após a refeição,
 - Sugere-se oferecer com uma fruta ou um pouco de suco cítrico para melhor absorção do ferro.

Fonte: NGQP, 2025.



3.2. Vitamina A 50.000UI + Vitamina D3 10.000 UI/mL

Em puericultura, a suplementação de vitamina A e vitamina D pode ser recomendada em diferentes contextos, visando prevenir deficiências e garantir o desenvolvimento saudável das crianças, mas a prescrição ou não deste item deverá ser avaliada de maneira individual e conforme conduta médica.

Quadro 04. Prescrição de vitamina A e vitamina D na Puericultura

SUPLEMENTO	PRESCRITOR	ORIENTAÇÕES GERAIS
Vitamina A 50.000UI + Vitamina D3 10.000 UI/mL	Médicos	❖ Crianças 0 a 24 meses ➢ Vitamina A 50.000UI + Vitamina D3 10.000 UI/mL - 2 gotas ao dia*, conforme bula.
IMPORTANTE: ❖ *Atentar-se a concentração do produto disponível na farmácia, para cálculo das gotas correspondentes para proceder a prescrição; ❖ A prescrição ou não da Vitamina A + D, deverá ser avaliada de maneira individual e conforme conduta médica; ❖ Não realizar a administração diretamente na boca, utilizando sempre uma colher para a dosagem.		

Fonte: NGQP, 2025.



REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Federal de Nutricionistas (CFN). **Resolução CFN nº 731, de 21 de agosto de 2022**. Altera as Resoluções CFN nº 656, de 15 de junho de 2020, que dispõe sobre a prescrição dietética, pelo nutricionista, de suplementos alimentares, e nº 680, de 19 de janeiro de 2021, que regulamenta a prática da fitoterapia pelo nutricionista. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, n. 160, p. 103, 23 ago. 2022. Disponível em: <https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cfn-n-731-de-21-de-agosto-de-2022-425012650>.

Acesso em 4 ago. 2025;

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Instrução Normativa nº 102, de 16 de novembro de 2021**. Estabelece as listas de constituintes, limites de uso, alegações e rotulagem complementar dos suplementos alimentares. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 17 nov. 2021. Disponível em: <https://anvisa.gov.br/web/dou/-/instrucao-n-102-de-16-de-novembro-de-2021-425012650>. Acesso em 4 ago. 2025;

BRASIL. Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (COREN-SC). **Protocolo de Enfermagem – Volume 3: Saúde da Mulher** – Acolhimento às demandas da mulher nos diferentes ciclos de vida. Florianópolis - SC: 2016 (atualizado em dez. 2020);

BRASIL. Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (COREN-SC). **Protocolo de Enfermagem – Volume 5: Atenção à Demanda de Cuidados na Criança**. Florianópolis - SC: 2018 (atualizado em dez. 2020);

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Gestão do Cuidado Integral. Coordenação-Geral de Atenção à Saúde das Mulheres. Coordenação de Enfrentamento à Mortalidade Materna. Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde. Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição. **Nota Técnica Conjunta nº 251/2024-COEMM/CGESMU/DGCI/SAPS/MS e CGAN/DEPPROS/SAPS/MS**. Brasília - DF: 2024;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Nota Técnica Conjunta nº 251/2024 – Suplementação de cálcio durante a gestação**. Brasília - DF: 2024;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Programa Nacional de Suplementação de Ferro: manual de condutas gerais**. Brasília - DF: 2013;

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria SAS/MS nº 1.247, de 10 de novembro de 2014**. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Anemia por Deficiência de Ferro. Brasília - DF: 2014;

BRASIL. Ministério da Saúde. Diário Oficial da União. **Portaria nº 2.436, de 21 de**



setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília - DF: 2017;

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia (CFF). **Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013.** Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 30 ago. 2013. Seção 1, p. 146;

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia (CFF). **Resolução nº 586, de 29 de agosto de 2013.** Regulamenta a prescrição farmacêutica e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 30 ago. 2013. Seção 1, p. 147;

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014.** Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. Diário Oficial da União, Brasília, 11 ago. 2014. Seção 1, p. 1;

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009.** Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de medicamentos e produtos correlatos em farmácias e drogarias. Diário Oficial da União, Brasília, 18 ago. 2009. Seção 1, p. 74;

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia (CFF). **Resolução nº 5, de 17 de março de 2025.** Dispõe sobre o ato de estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento sistemático do paciente pelo farmacêutico e dá outras providências]. Diário Oficial da União, Brasília, 17 mar. 2025. Seção 1;

INTERNATIONAL LIFE SCIENCES INSTITUTE BRASIL (ILSI Brasil). **Recomendações de nutrientes para a população brasileira.** Brasília, DF: ILSI Brasil, 2024. Disponível em:

<https://ilsibrasil.org/wp-content/uploads/sites/9/2024/02/Recomendacoes-de-Nutrientes-Digital-Final.pdf>. Acesso em: 4 ago. 2025;

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Diretoria de Políticas de Saúde. Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal. Sistema Eletrônico de Informação - SEI. **Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) – Guia para Profissionais de Saúde.** Joinville: SC: 2020;

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Diretoria de Assistência à Saúde. Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial. Sistema Eletrônico de Informação - SEI. **Protocolo de Pré-Natal.** Joinville: SC: 2019;

SÃO PAULO. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Nutrologia. **Nutrologia pediátrica: temas da atualidade em nutrologia pediátrica.** São Paulo - SP: 2021.

